Matriz SWOT – Projeto Obesidade (UAC)

Internos

Positivos

F - Fortes

- 1. Médico com experiência em manejo da obesidade e fluxo pré-bariátrico;
- 2. Captação ativa de pacientes a partir da carteira do profissional e das fontes da UAC;
- 3. Grande volume populacional com potencial de população elegível para cirurgia bariátrica;
- 4. Apoio da Rede Américas e possibilidade de articulação com centros cirúrgicos;
- 5. Visão estratégica de conversão de casos clínicos elegíveis em desfechos cirúrgicos resolutivos.

W - Fracos

- 1. Dependência inicial da demanda do profissional e da adesão da equipe multiprofissional;
- 2. Falta de carteira de convênios que facilite acesso a procedimentos cirúrgicos em alguns contextos;
- 3. Ausência prévia de linha estruturada pré e pós-bariátrica na UAC;
- 4. Metodologia de captação ativa e triagem cirúrgica ainda em implantação.

Negativos

O - Oportunidades

- 1. "Know-how" a ser adquirido em manejo pré e pós-operatório da obesidade grave;
- 2. Consolidação da UAC como porta de entrada qualificada para cirurgia bariátrica;
- 3. Falta de credibilidade e resolutividade em concorrentes, abrindo espaço para um programa estruturado;
- 4. Possibilidade de giro para outras oportunidades em linhas de cuidado cirúrgico, com base na experiência acumulada em obesidade;
- 5. Ampliação do acesso da população elegível à cirurgia bariátrica com fluxos mais transparentes e critérios claros.

T - Riscos

- 1. Perda do profissional capacitado ou de lideranças-chave do programa;
- 2. Baixa quantidade de população elegível efetivamente convertida em encaminhamentos cirúrgicos;
- 3. Restrição de vagas cirúrgicas, filas prolongadas ou mudanças na rede de referência;
- 4. Frustração dos pacientes se a taxa de conversão cirúrgica entre elegíveis for baixa;
- 5. Sobrecarga assistencial caso não haja equilíbrio entre demanda clínica e capacidade cirúrgica.

Externos